

Nach implantologischen Eingriffen

Wunde schützen, Implantate entlasten und die Heilung unterstützen

Diese Hinweise gelten nach Implantation, Implantat-Freilegung sowie Knochen- oder Weichgewebsaufbau. Umfang und Lage des Eingriffs bestimmen Ihre Nachsorge. **Ihr persönlicher Behandlungsplan hat Vorrang.**

Nicht auf den frisch operierten Kieferkamm beißen.

Keine feste Nahrung direkt auf der Operationsstelle kauen. Druck und wiederholte Bewegungen können Wundverschluss, Knochenaufbau und Einheilung stören. Schonen Sie den Bereich auch dann, wenn er nicht schmerzt. Nicht mit Zunge, Fingern oder Gegenständen an Implantaten und Nähten prüfen, ob alles fest sitzt.

Essen ohne Druck auf das Operationsgebiet

Erst essen, wenn die Betäubung vollständig abgeklungen ist; bis dahin nichts kauen und nichts Heißes trinken. Anschließend weiche, kühle bis lauwarme Speisen wählen, etwa Kartoffelpüree, Rührei oder weiches Gemüse. Harte Krusten, Nüsse und rohe feste Lebensmittel können die Wunde belasten. Ausreichend trinken und auf nährstoff- und eiweißreiche Kost achten.

Wenn möglich, nur auf der **nicht operierten Seite** kauen. Sind beide Seiten betroffen oder ist ein Ausweichen nicht möglich, vorübergehend pürierte beziehungsweise sehr weiche Kost ohne Kaudruck wählen. Die Entlastung endet nicht automatisch nach einer Woche oder mit dem Fadenzug, sondern **erst nach unserer Freigabe**.

Prothesen und Provisorien müssen druckfrei sein

Vorhandenen Zahnersatz nur tragen, wenn wir ihn kontrolliert, bei Bedarf angepasst und freigegeben haben. Auch eine scheinbar gut sitzende Prothese kann Druck auf die Wunde ausüben. Wir legen fest, ob und wann ein herausnehmbarer Ersatz getragen werden darf.

Bei Druckstellen oder Lockerung nicht weiter damit kauen und zeitnah Kontakt aufnehmen. Einen herausnehmbaren Ersatz bei Wunddruck abnehmen, sofern nichts anderes vereinbart wurde. Feste Provisorien nicht selbst lösen oder nachschleifen. Für eine Sofortversorgung gilt ein eigener Belastungs- und Ernährungsplan.

Die ersten Stunden

Ruhen Sie sich aus, halten Sie den Oberkörper erhöht und kühlen Sie von außen etwa zehn Minuten, dann pausieren. Ein Tuch schützt die Haut; kein Eis direkt auflegen und keinen Druck ausüben. Nach örtlicher Betäubung nicht selbst fahren; ÖPNV ist grundsätzlich möglich. Nach Sedierung/Narkose sind Abholung aus der Praxis und Betreuung verpflichtend: mindestens 24 Stunden keine Fahrzeuge, Maschinen, wichtigen Entscheidungen oder Alkohol; längere Vorgaben des Narkoseteams beachten.

Mundhygiene während der Wundheilung

Ein sauberer Mund unterstützt die Heilung. Die frische Wunde braucht gleichzeitig Schutz vor mechanischer Reizung. Lassen Sie sich zeigen, welche Bereiche Sie bereits reinigen dürfen.

- **Übrige Zähne:** zweimal täglich vorsichtig putzen. Den übrigen Mund nicht wegen der Operation ungeputzt lassen.
- **Wundbereich und Nähte:** zunächst nicht direkt bürsten. Zeitpunkt und Technik der Reinigung werden bei der Kontrolle festgelegt; häufig wird der unmittelbar operierte Bereich in der ersten Woche ausgespart, bei Aufbauten gegebenenfalls länger.
- **Nach Freigabe:** mit einer weichen beziehungsweise chirurgischen Bürste behutsam reinigen. Sichtbare Einheilkappen erhalten einen eigenen Pflegeplan.
- **Vermeiden:** Munddusche, Spülspritzen, Zahnseide oder Interdentalbürsten an der frischen Wunde ohne ausdrückliche Anleitung. Nicht an Fäden ziehen, Wundbeläge abkratzen oder die Lippe zur Kontrolle der Naht stark abziehen.

Desinfizierende Mundspüllösung

Am Operationstag nicht kräftig spülen oder ausspucken. Eine verordnete antiseptische Lösung wird üblicherweise **ab dem Folgetag** als sanftes Mundbad angewendet. Halten Sie sich an das verordnete Präparat und den persönlichen Zeitplan.

Beispiel nur bei entsprechender Verordnung: alkoholfreie Chlorhexidin-Lösung 0,2 %, zweimal täglich 10 ml für etwa eine Minute sanft im Mund halten, danach vorsichtig auslaufen lassen. Üblicherweise zeitlich begrenzt, etwa 7–14 Tage; die konkrete Dauer legen wir fest. Andere Konzentrationen können anders dosiert werden.

Nicht schlucken und nicht mit Wasser nachspülen. Anschließend mindestens 30 Minuten nichts essen oder trinken. Zeitlich getrennt vom Zähneputzen anwenden, da Zahnpastabestandteile die Wirkung beeinträchtigen können; die Gebrauchsinformation beachten.

Die Lösung ersetzt das Zähneputzen nicht und soll nicht unbegrenzt verwendet werden. Vorübergehende Verfärbungen, Geschmacksveränderungen und Schleimhautreizungen sind möglich. Bei Unverträglichkeit absetzen und Rücksprache halten; bei Atemnot oder starker allergischer Schwellung sofort 112. Bekannte Chlorhexidin-Allergie unbedingt angeben.

Zusätzlich nach Knochenaufbau oder Sinuslift

Nähte und eine sichtbare Membran nicht berühren oder selbst entfernen. Bei Wundöffnung, sichtbarem Aufbaumaterial oder auffälligem Austritt von Körnchen zur Kontrolle melden. Nicht versuchen, die Stelle selbst zu säubern.

Nach Sinuslift: mindestens eine Woche nicht schnäuzen oder kräftig die Nase hochziehen, mit offenem Mund niesen. Mindestens zwei Wochen nicht fliegen oder tauchen; bei ausgedehnten Eingriffen länger. Die persönliche Freigabe und gegebenenfalls Nasenmedikation sind maßgeblich.

Schmerzen und Medikamente

Die Tabelle nennt den **Erwachsenen-Praxisstandard nach individueller Freigabe**. Körpergewicht, Schwangerschaft, Magen-, Nieren- oder Lebererkrankungen und andere Medikamente können niedrigere Dosen oder andere Mittel erfordern. Für Kinder und Jugendliche gilt ein eigener Plan nach Alter und Gewicht.

Mittel	Einnahme bei Eignung	Hinweis
Ibuprofen 600 mg	Alle 6–8 Std., max. 3×/Tag	Nicht nüchtern
Paracetamol 500–1000 mg	Alternativ/ergänzend alle 6 Std.	Max. 4 g/Tag; nicht für alle Körpergewichte geeignet
Novalgin-Tropfen	Bis zu 4×30 Tropfen täglich, nur verordnet	Nur bei 500 mg/ml und 20 Tropfen/ml
Kein Aspirin/ASS zusätzlich	Als Schmerzmittel meiden	Verordnete ASS-Dauertherapie nicht selbst absetzen

Bei Fieber, Schüttelfrost, Halsschmerzen oder schmerzhaften Schleimhautveränderungen unter Novalgin/Metamizol: **sofort absetzen und dringend ärztlich abklären**. Keine paracetamolhaltigen Kombinationsmittel zusätzlich ohne Rücksprache einnehmen.

Keine zwei entzündungshemmenden Schmerzmittel wie Ibuprofen und Diclofenac kombinieren. Antibiotika nur einnehmen, wenn verordnet, und genau nach dem vereinbarten Plan; keine Restbestände verwenden. Bei Ausschlag, starkem Durchfall oder anderen auffälligen Nebenwirkungen Rücksprache halten. Verordnete Gerinnungshemmer einschließlich ASS nicht eigenständig absetzen.

Was ist im Heilungsverlauf zu erwarten

- **Erste Tage:** Wundschmerz, Schwellung, Bluterguss und leicht blutig gefärbter Speichel können vorkommen. Die Schwellung erreicht häufig am zweiten oder dritten Tag ihren Höhepunkt und sollte danach zurückgehen.
- **Kontrolltermin:** wie vereinbart wahrnehmen, auch bei wenig Beschwerden. Fäden werden meist nach 1–2 Wochen entfernt; bei größeren Aufbauten kann eine spätere Entfernung sinnvoll sein.
- **Weitere Einheilung:** Eine geschlossene Schleimhaut bedeutet noch keine volle Belastbarkeit. Implantate heilen häufig über mehrere Monate ein; Knochenaufbau kann die Zeit verlängern. Erst nach Untersuchung wird die weitere Belastung freigegeben.

Was Sie selbst zur Heilung beitragen können

Sport und Wärme: mindestens eine Woche kein Sport, schweres Heben oder starke körperliche Anstrengung. Nach größerem Knochenaufbau kann eine längere Pause nötig sein. Sauna, heiße Bäder und starke Hitze in der frühen Heilungsphase meiden; Rückkehr nach persönlicher Freigabe.

Nikotin und Alkohol: mindestens vier Wochen nicht rauchen oder vaper, möglichst dauerhaft darauf verzichten. Rauchen erhöht das Risiko für Wundheilungsstörungen und Implantatverlust. In der frühen Heilungsphase keinen Alkohol trinken, insbesondere bei Schmerzmitteln, Antibiotika oder nach Sedierung.

Allgemeinerkrankungen: Diabetes gut einstellen lassen und ausreichend essen und trinken. Bei Problemen mit der Nahrungsaufnahme oder der regelmäßigen Medikation frühzeitig melden.

Warnzeichen und richtiges Verhalten

Bitte zeitnah, bei stärkeren Beschwerden sofort melden: anhaltende oder starke Blutung, zunehmende Schmerzen oder Schwellung nach anfänglicher Besserung, Fieber, Eiter, auffälliger Geruch mit Beschwerden, Wundöffnung oder eine Prothese, die auf die Wunde drückt.

Lockere Einheilkappe, Schraube oder Versorgung: nicht weiter belasten, nicht selbst festdrehen und die Praxis kontaktieren. Ein bereits herausgefallenes Teil aufbewahren, nicht selbst wieder einsetzen. Bleibt nach dem erwarteten Abklingen der Betäubung eine Taubheit an Lippe, Kinn oder Zunge bestehen, noch am selben Tag Rücksprache halten.

Bei Nachblutung

Aufrecht hinsetzen, ruhig bleiben, nicht kräftig spülen. Falls so gezeigt, einen sauberen Tupfer gezielt auf die zugängliche blutende Wunde legen und etwa 20–30 Minuten gleichmäßig drücken. **Dieser gezielte Wunddruck zur Blutstillung ist eine Ausnahme; nicht auf Implantat, Aufbau oder Provisorium beißen.** Ist die richtige Druckstelle unklar oder stoppt die Blutung nicht, sofort Kontakt aufnehmen. Nicht mit einem Tupfer im Mund einschlafen.

Bei Warnzeichen sofort Kontakt aufnehmen

Praxis: **06151 786540**. Nach der OP außerhalb der Praxissprechzeiten: **+49 151 10437450**. Falls nicht erreichbar: zahnärztlicher Notdienst **01805 60 70 11**.

Bei lebensbedrohlicher Notlage, Atemnot, starker Schluckbehinderung oder rascher Schwellung von Mundboden, Hals oder Zunge: **sofort 112**.

Nach der Einheilung: Häusliche Implantatpflege, professionelle Reinigung und regelmäßige zahnärztliche sowie chirurgische Kontrollen bleiben wichtig. Weitere Informationen: [Implantat-Recall öffnen ↗](#).



Ihre Nachsorgeinformation online

patienteninfo.mkg-im-carree.de/implantat-nachsorge/

QR-Code mit dem Smartphone scannen.

Fachliche Grundlagen: Guy's and St Thomas': After having a dental implant; Cambridge University Hospitals: Dental implants; CUH: Bone grafting; NHS: Chlorhexidine. Abruf 25.09.2026. Ergänzt um den individuellen Praxisablauf MKG im Carree. Diese Information ersetzt keine persönliche Untersuchung.